黄连温胆汤辅治脑卒中后言语功能障碍临床研究

刘利哲
（河南省洛阳市中医院康复医学科，河南 洛阳 471000）

［中图分类号］R743.3　［文献标识码］B　［文章编号］1004-2814（2024）06-1092-03

［摘　要］　目的：观察黄连温胆汤辅治脑卒中后言语功能障碍的效果。方法：80例用简单随机分组法分为两组，两组均用西药治疗，研究组加用黄连温胆汤。结果：治疗后BDAE评分、语言能力评分、日常生活能力及生活质量（生理、沟通、心理社会）评分研究组均较常规组高（$P<0.05$）。总有效率研究组高于常规组（$P<0.05$）。治疗后两组不良反应比较差异无统计学意义（$P>0.05$）。结论：黄连温胆汤辅治脑卒中后言语功能障碍可提高疗效。

［关键词］　脑卒中；言语功能障碍；黄连温胆汤

脑卒中包括脑出血、脑梗死，已成为世界范围内第二致死致残病因[1]。脑卒中的诊断与治疗手段不断完善，已经极大地减少了脑卒中发生后的临床病死率，但仍有一部分会出现不同程度的神经系统损伤，

是POF的前期表现，早期发现并治疗DOR可在一定程度上延缓/逆转POF[7]。芬吗通是雌孕激素复方制剂，包括雌二醇片（白色）和雌二醇地屈孕酮片（灰色），前者含雌二醇1mg，为最具活性的卵巢激素，可参与子宫内膜增生及宫颈、阴道的周期性变化，还可影响自主神经系统活动；后者含雌二醇1mg和地屈孕酮10mg，地屈孕酮为一种孕激素，可使子宫形成完全的分泌期内膜，保护子宫避免因雌激素持续作用而增加子宫内膜厚度，且无雄激素的副作用。

DOR属中医“月经过少”、“闭经”、“不孕”等范畴。肾主生殖，可影响女性生殖机能的发育、旺盛与衰退，与卵巢功能密切相关[8]。徐珊等[9]认为DOR的病位在肾，可累及心、肝、脾等脏器，根本病机为肾虚，兼之肝郁、气滞、血瘀、脾虚、痰湿等，肾气不足、胞脉失养，出现月经量少或闭经；肾阳虚血行迟缓，出现血瘀，阻塞冲任、胞宫，血枯，新血不生而月经难至。治疗以补肾为主。杨文文等[10]对补肾法治疗DOR的有效性及优势进行总结，显示补肾法可改善性激素水平及超声指标，且补肾填精法可明显降低FSH水平、升高AMH水平、改善AFC。补肾益精汤方中山药健脾益肾、滋肾益精，菟丝子补益肝肾、固精缩尿，山茱萸滋补肝肾、涩精固脱，熟地黄、续断、桑寄生、女贞子、墨旱莲滋补肝肾，茯苓健脾宁心、利水渗湿，炒白术补气健脾，陈皮理气健脾，醋柴胡和解退热、疏肝解郁、升举阳气，砂仁行气止痛、温中散寒、疏肝理气。诸药合用，共奏补肾益精、滋阴清热之效。

DOR患者的卵泡数目减少，使得其分泌雌激素含量也相应减少，减弱了垂体分泌FSH的抑制作用，导致血清FSH、LH水平升高。研究显示[11]，与血清E_2水平比较，血清FSH水平的变化出现得更早。补肾益精汤可调节性激素水平。药理研究表明，菟丝子、山茱萸可增强黄体功能，增加子宫蜕膜孕激素受体的含量，还可直接作用于卵巢，促进卵巢的发育成熟，提高E_2水平。

补肾益精汤辅治DOR可提高疗效。

［参考文献］
［1］万凌屹，丁彩飞，俞佳.补肾活血方治疗肾虚血瘀型卵巢储备功能下降临床观察［J］.中华中医药学刊，2018，36（2）：432-434.
［2］刘柳青，刘雁峰，王悦竹，等.补肾调肝方对卵巢储备功能下降合并慢性心理应激大鼠卵巢功能的影响及机制研究［J］.中华中医药杂志，2022，37（8）：4459-4465.
［3］什佩罗夫，李继俊译.临床妇科内分泌学与不孕［M］.济南：山东科学技术出版社，2003.
［4］郑筱萸.中药新药临床研究指导原则（试行）［M］.北京：中国医药科技出版社，2002.
［5］国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准［M］.南京：南京大学出版社，1994.
［6］中华医学会.临床诊疗指南：妇产科学分册［M］.北京：人民卫生出版社，2007.
［7］陈卫红，张倩平.芬吗通在60例卵巢储备功能下降及卵巢早衰治疗中的疗效评价［J］.上海医药，2020，41（17）：17-19.
［8］庞俏茹，吴丹，庞卓超，等.补肾调经汤对卵巢储备功能下降月经后期、过少患者卵巢功能及性激素水平的影响［J］.现代中西医结合杂志，2021，30（14）：1544-1547，1551.
［9］徐珊，张小菜，袁宁霞.滋肾温阳汤联合克龄蒙治疗卵巢储备功能下降45例［J］.山东中医杂志，2021，40（1）：5248-5264.
［10］杨文文，杨琪，崔楠，等.补肾法治疗卵巢储备功能下降随机对照研究文献的系统评价［J］.中国中医基础医学杂志，2021，27（6）：978-985.
［11］苗飞飞，徐慧军，韩新波.调经汤对肾阴虚型卵巢储备功能下降患者子宫动脉血流参数及激素的影响［J］.四川中医，2017，35（3）：121-123.

［收稿日期］2023-10-30

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

其中语言障碍最常见[2]。大约1/3的脑卒中伴有语言障碍。语言障碍是由多种脑血管意外导致与语言相关的神经环路受损，致使言语和文字表达能力下降，理解通路受阻，整体表现为语言能力下降和丧失。脑卒中患者的语言功能受损后会影响日常沟通，康复训练的配合及生活质量也会随之降低[3-4]。有效的治疗手段对于降低脑卒中后致残风险有十分重要的意义[5]。黄连温胆汤有改善脑循环和神经元功能，促进侧支循环的建立与开放[6]。本研究用黄连温胆汤辅治脑卒中后言语功能障碍效果较好，报道如下。

1 临床资料

共80例，均为2021年12月至2023年12月本院治疗患者，采用简单随机分组法分为研究组和常规组各40例。研究组男24例，女16例；年龄45～70岁，平均（57.15±6.12）岁；病程4～5周，平均（4.35±0.58）周；高血压12例，糖尿病8例。常规组男15例，女25例；年龄45～70岁，平均（57.35±6.35）岁；病程4～5周，平均（4.15±0.62）周；高血压9例，糖尿病10例。两组一般资料比较差异无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性。

纳入标准：①符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[7]脑卒中诊断标准，符合失语、部分失语、不能言语等言语功能障碍诊断标准。中医辨证分型为痰热扰心证，以失眠、心烦、眩晕胸闷、舌苔黄为主；②已经度过卒中急性阶段，身体状况较为平稳，可以配合各项检查和治疗；③无其他疾病导致言语功能障碍；④母语为汉语，没有明显的听、视觉障碍。

排除标准：①存在用药禁忌症；②有精神类疾病；③有其他心、肾、肝器官严重病变；④格拉斯哥评分低于15分。

2 治疗方法

两组均用低盐低脂的健康饮食、戒烟酒、神经功能康复训练、降血压、降血脂、改善微循环以及营养脑神经等治疗。用胞磷胆碱钠片（四川梓橦宫药业股份有限公司生产，国药准字H20060389）0.2g，日3次。并接受常规语言康复训练，根据具体情况进行健康教育。

研究组加用黄连温胆汤治疗。药用胆南星10g，陈皮10g，甘草8g，竹茹10g，熟大黄10g，姜半夏10g，茯神20g，瓜蒌仁15g，郁金15g，黄连10g。每日1剂，加水煎至500mL，分2次于早晚饭后服用，日2次。

两组均持续治疗4周。

3 观察指标

失语严重程度采用波士顿诊断性失语症检查量表（BDAE）进行评估[8]，分为0～5级，分别对应0～5分。0级为不能听懂任何意思的话；1级为语言交际中存在语言表达不流畅，大多数情况下都要听者去提问或猜测，传达的信息量很小，使讲述者很难在语言交际中获得成功；2级为在听者的协助下，可以就熟悉的话题进行对话，但是对于不熟悉的话题，往往无法将自己的想法说出来，让患者和听者都觉得语言沟通有问题；3级为只需要很少的帮助或者不需要任何帮助就能进行任意交谈，但是因为语言和理解力的下降，导致一些对话变得困难或者不可能；4级为语言流畅，能够感觉到理解的困难，但是思维与语言的表达还没有受到显著的约束；5级为仅有少数可辨别的言语障碍，患者在主观上也许会有些困难，但是听者不能清楚地感觉到。分数越高表示语言能力越好。

语言能力评定根据《汉语失语症检查法》为标准[9]，由理解、复述、书写和阅读4个部分组成，总分为200分，评分越高表示语言功能恢复越好。

日常生活能力评估以Barthel指数为参考[10]，评分与生活自理能力成正相关。

生活质量用脑卒中失语症患者生活质量量表（SAQOL-39）评估[11]，包括生理、沟通、心理社会3个维度，39条项目，每项0～4分，得分越高表示生活质量越好。

不良反应发生情况，包括血压下降、恶心、呕吐、腹泻等。

用SPSS22.0统计学软件分析，计量资料以（$\bar{x}\pm s$）表示、用t检验，计数资料以（%）表示、用χ^2检验，$P<0.05$为差异有统计学意义。

4 疗效标准[12]

治愈：失语严重程度分级提高2级，言语功能改善90%以上。显效：失语严重程度分级提升2级，治疗后言语功能得分提高60%～90%。有效：失语严重程度分级提高1级，言语功能得分提高30%～60%。无效：言语功能得分提高低于30%，失语严重程度分级无明显改善。

5 治疗结果

两组治疗前后BDAE评分、语言能力评定比较见表1。

表1 两组治疗前后BDAE评分、语言能力评定比较 （分，$\bar{x}\pm s$）

组别	例	BDAE评分		语言能力评定	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
常规组	40	3.13±1.02	3.57±0.94*	108.65±12.34	142.26±15.14*
研究组	40	3.08±0.98	4.25±0.52*△	107.54±11.55	178.22±16.36*△

注：与本组治疗前比较，*$P<0.05$；与常规组治疗后比较，△$P<0.05$。

两组治疗前后日常生活能力及生活质量比较见表2。

表2 两组治疗前后日常生活能力及生活质量比较 （分，$\bar{x}\pm s$）

组别	例	日常生活能力		生理		沟通		心理社会	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
常规组	40	46.85±8.42	65.33±9.14*	36.45±5.23	41.52±6.74*	15.15±3.69	21.25±5.72*	33.52±7.21	45.82±8.46*
研究组	40	46.23±8.55	84.13±10.74*△	36.05±5.11	54.25±9.05*△	15.03±3.85	27.32±6.88*△	33.24±57.35	49.23±9.47*△

注：与本组治疗前比较，*$P<0.05$；与常规组治疗后比较，△$P<0.05$。

两组临床疗效比较见表3。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

运脾化痰通窍方辅治小儿腺样体肥大脾虚痰阻型临床观察

周星月，王毛毛
（河南省新密市妇幼保健院，河南 新密 452370）

［中图分类号］R767.19　［文献标识码］B　［文章编号］1004-2814（2024）06-1094-03

［摘　要］　目的：观察运脾化痰通窍方辅治小儿腺样体肥大（AH）脾虚痰阻型的临床效果。方法：60例按随机数字表法分为两组各30例。两组均予以西药治疗，观察组加用运脾化痰通窍方治疗。结果：总有效率观察组较对照组高（$P<0.05$），治疗后鼻塞、张口呼吸、打鼾、睡眠不安评分低于对照组（$P<0.05$），治疗后CRP、IL-2、IL-6水平观察组低于对照组（$P<0.05$），复发率观察组低于对照组（$P<0.05$），两组不良反应比较差异无统计学意义（$P>0.05$）。结论：运脾化痰通窍方辅治AH效果较好，可加快症状消失，降低复发风险，且安全。

［关键词］　小儿腺样体肥大；运脾化痰通窍方；对照治疗观察

腺样体肥大（AH）可引起周围炎症反应，诱发鼻塞、打鼾、流涕，并可影响颌面部的发育[1-2]。治疗分为保守治疗与手术治疗两类，轻症多以保守治疗为主，用抗炎、抗组胺类药物能够减轻局部炎症反应，促使腺样体缩小，缓解症状[3-4]。但单纯西药治疗效果有限，停药后易出现复发。运脾化痰通窍方有健脾化痰、宣通鼻窍等功效[5]。本研究用运脾化痰通窍方辅治AH效果较好，报道如下。

1　临床资料

共60例，均为我院2021年3月至2023年3月收治

表3　两组临床疗效比较　例（%）

组别	例	治愈	显效	有效	无效	总有效率
常规组	40	11（27.50）	7（17.50）	12（30.00）	10（25.00）	（75.00）
研究组	40	17（42.50）	9（22.50）	11（27.50）	3（ 7.50）	（92.50）△

注：与常规组比较，△$P<0.05$。

两组不良反应发生情况比较见表4。

表4　两组不良反应发生情况比较　例（%）

组别	例	血压下降	恶心	呕吐	腹泻	发生率
常规组	40	0（.00）	1（2.50）	1（2.50）	0（.00）	（5.00）
研究组	40	0（.00）	1（2.50）	0（.00）	0（.00）	（2.50）

注：与常规组比较，△$P<0.05$。

6　讨　论

黄连温胆汤源于《六因条辨》，可通利三焦、清热利湿、益气健脾、化痰燥湿。方中黄连清热燥湿、泻火解毒，半夏化痰利脾、开郁通窍，竹茹清神醒脑、止呕除烦，甘草调和诸药。药理研究显示，黄连温胆汤有调节大脑神经元递质、维持神经细胞膜稳态、修复脑神经等功效。

黄连温胆汤辅治脑卒中后言语功能障碍可提高疗效。

［参考文献］

［1］本刊编辑部.2023年7期《临床内科杂志》综述与讲座——“急性缺血性卒中的介入再通治疗”栏目导读［J］.临床内科杂志，2023，40（7）：448-448.
［2］田伟，魏嘉，李倩倩，等.贺氏三通法联合化痰通络方治疗脑卒中后语言障碍临床研究［J］.中医药信息，2020，37（2）：91-95.
［3］张雯舒，刘小平，陈飞宇，等.眼针联合言语康复对缺血性脑卒中患者身体机能及语言障碍的疗效分析［J］.中国药物与临床，2020，20（2）：246-248.
［4］夏彬，李晶，朱洪山.经颅磁刺激联合星状神经节阻滞对脑卒中后语言功能障碍恢复和生活质量的影响［J］.实用医院临床杂志，2020，17（6）：135-138.
［5］朱化珍，王萍，陈德兴，等.地黄饮子定向透药治疗肾虚痰瘀型脑卒中后吞咽障碍患者的疗效及其对生存质量的影响［J］.医学临床研究，2023，40（6）：838-844.
［6］王雅娟，刘玉洁，段红莉，等.黄连温胆汤加味治疗卒中后抑郁症的效果及对脑神经代谢物表达水平的影响［J］.中国医药导报，2019，16（32）：75-78，94.
［7］中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014［J］.中华神经科杂志，2015，48（4）：246-257.
［8］员玲玲，王欣，李越.镜像神经元康复疗法治疗脑卒中后运动性失语症的疗效观察［J］.听力学及言语疾病杂志，2020，28（5）：527-530.
［9］任媛媛，杨柳，张小霜.方氏头针结合醒脑开窍针法治疗中风后运动性失语临床研究［J］.陕西中医，2022，43（1）：118-120.
［10］李雪娜，海英.清脑益元汤对缺血性中风患者的疗效及Barthel指数、ADL评分的变化研究［J］.中医药学报，2020，48（9）：46-49.
［11］林润，陈锦秀，冯木兰，等.脑卒中失语症患者生活质量量表汉化及信效度测评［J］.中华护理杂志，2013，48（4）：349-351.
［12］李止戈，孙善斌.针刺舌三针联合言语康复训练治疗脑卒中后言语障碍疗效观察［J］.辽宁中医药大学学报，2019，21（3）：167-170.

［收稿日期］2024-04-08

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net